

05. 循環器系の更新

所要時間 : 03:59

学習シート

コース概要

このビデオは、従来の循環器系のモデルを深く更新し、実際には3つの異なる静脈系が存在することを実証しています。血液と心臓の間の複雑な相互作用、および血液がたどることができるさまざまな経路について学び、循環の固有の知性を示します。M. HerveillatやM. Batsonのような先駆者の理論は、静脈の役割を再考し、基幹静脈系、卵黄静脈系、臍帯静脈系を詳細に理解することを可能にします。腰痛や局所的な酸性度などの一般的な病状に対する実践的な影響も取り上げられ、オステオパシーの診療を豊かにするための具体的なツールが提供されます。

循環器系：最新情報

血管経路の発達

循環器系の伝統的なイメージは、**動脈**を介して心臓から始まり、**静脈**を介して心臓に戻る回路です。これは事実ですが、実際には3つの異なる静脈系が存在します。

- **椎骨系**：椎骨系に排他的に関連しています。
- **門脈系**：外胚葉、中胚葉、内胚葉のすべての系を排出します。
- **第3のタイプの静脈系**。

血液は確かに心臓に戻りますが、心臓の圧力と減圧に応じて、Uターンしたり、他の経路をたどったりすることもあります。例えば、門脈系が過負荷で戻りが確保できない場合、血液は別の経路をたどります。それは、交換のための横隔膜領域を介して**下大静脈系**を利用します。

これは、圧力が調整できることを意味します。血液は単純な閉回路をたどるのではなく、さまざまな経路をたどることができます。このシステムには**内在的な知性**があり、常に心臓に戻ることを目指しています。

静脈系の新たな視点

血液は心臓から出て心臓に戻ります。しかし、静脈系、ひいては循環器系の私たちの見方は17世紀のもので、この概念は現在**刷新**されています。

この新しい理解の先駆者は、**M. Herveillat**と**M. Batson**です。疑問が生じます。「しかし、静脈には血液の逆流を防ぐための弁があると常に言われてきました。」実際には、これらの弁は**太い静脈**にのみ存在し、ネットワーク全体には存在しません。この種の小さな弁はごくわずかです。

研究すべきさまざまな静脈系

私たちは以下を研究します。

- **主静脈**：亜主静脈および上主静脈になります。
- **卵黄系**：肝臓に関連しています。
- **臍帯系**：椎骨-大静脈-門脈系に再マッピングされ、オステオパシーの診療に再統合されます。

主静脈系は非常に大きく変化するため、**外胚葉**と**中胚葉**の両方の構造に統合される組織や構造をどのように形成するかを詳細に見ていきます。

これを実践するための方法が開発されました。その意味を理解することが重要です。

実践的および臨床的意義

うっ滞と**腹圧**の変化は、重大な結果をもたらす可能性があります。例えば、**腰痛**は門脈系の過負荷の結果である可能性があります。

この場合、この門脈の過負荷によって椎骨系を「減圧」する必要があります。ここに**椎間板疾患**のメカニズム全体が関わってきます。

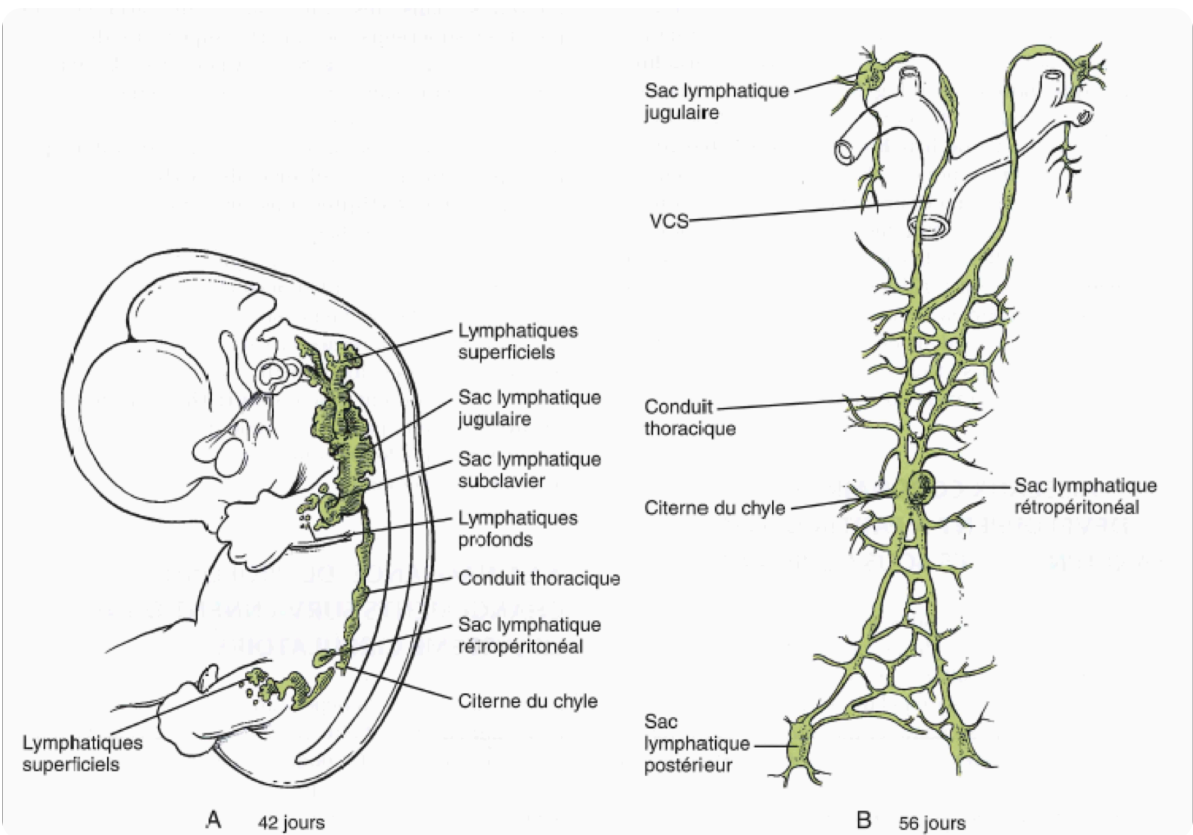
あらゆる形態のうっ滞は、局所的であっても**酸性度**を引き起こし、それを解決する必要があります。常に同じパターンが使用されます。例えば、**仙骨の腫瘍**には、ほとんど常に左腎臓、左肺、脳への**転移**が伴います。経路に一貫性が見られます。

前立腺の問題でも、同じパターンが見られます。さらに、椎骨静脈洞と小骨盤の仙骨静脈洞の間には**血管の連続性**があります。

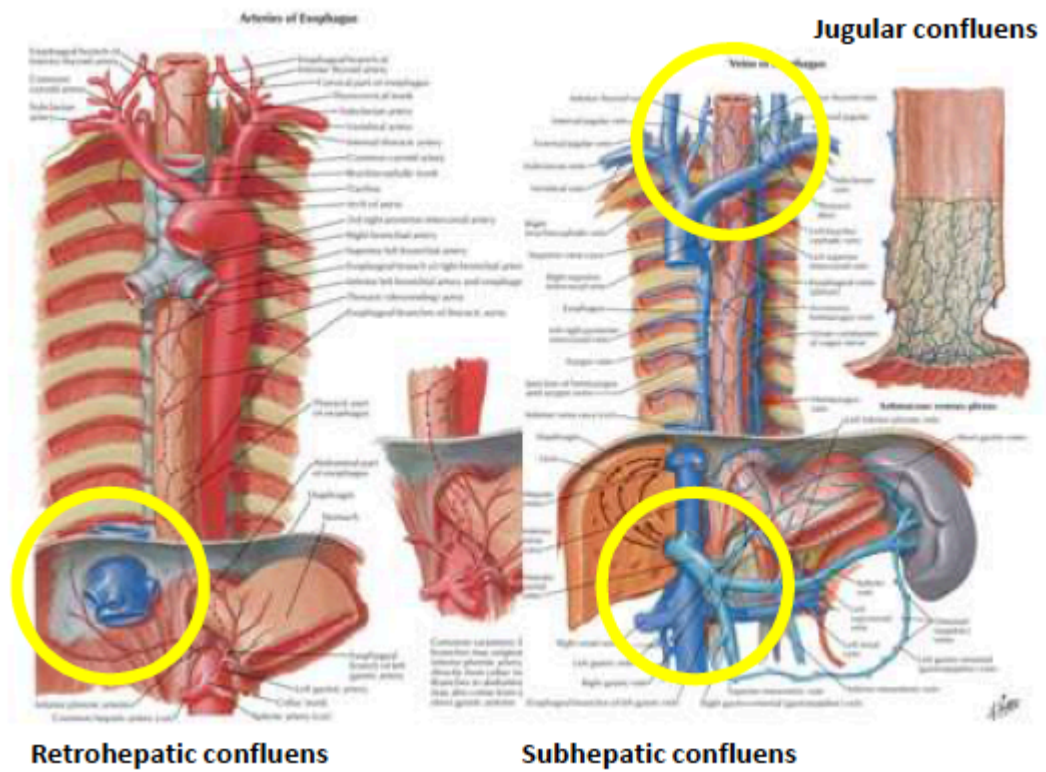
腕で行われた血液検査は、静脈系、動脈系、またはその他の系から採取できる血液の全体を反映するものではありません。



図一 心血管系



図一 リンパ系の発達



図一 食道側副静脈

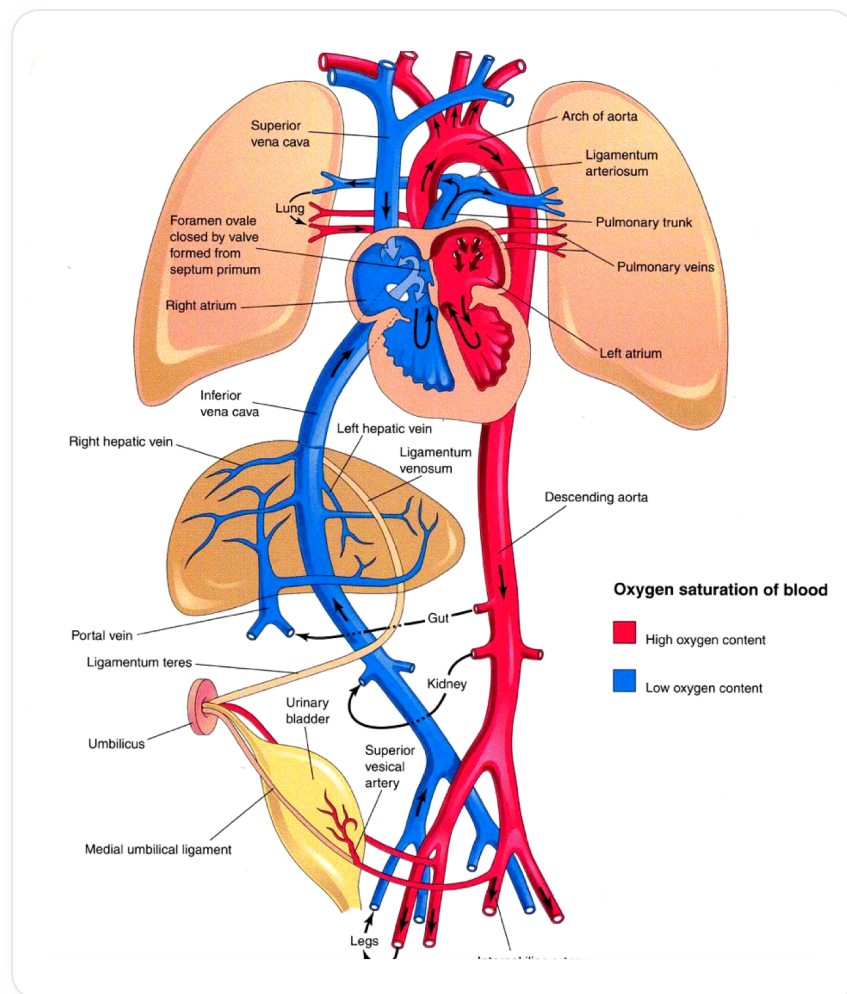


図 — ヒトの胎児循環